当院で分離した *Nocardia* spp.の臨床微生物学的検討

◎田中 美優[1)]、森 まどか[1)]、荒深 友菜[1)]、山下 和輝[1)]、岩井 遥奈[1)]、大澤 稜[1)]、建部 雅彦[1)]、大西 紀之[1)]
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター[1)]

Nocardia 属は土壌や水など自然界に広く存在する好気性の放線菌であり，特に免疫不全患者において感染症を引き起こす病原体である。当院にて 2020 年から 2026 年の 7 年間で *Nocardia* 属菌が分離された 10 症例について臨床微生物学的検討を行った。

全例が呼吸器検体からの検出であり，そのうち放線菌や真菌感染の疑いとして長期培養の依頼があったのは 4 例のみだった。塗抹検査にて分岐したグラム陽性桿菌を認めたものは 9 例であり，残りの 1 例は放線菌疑いの情報から延長培養を行い分離し得たものであった。4 例はステロイド治療や汎血球減少などの免疫不全を有していた。複合感染は 6 例で糸状菌 4 例が最多であり，基礎疾患として肺抗酸菌症を有するものが 3 例あった。分離した菌株は全て当院にて質量分析装置（MALDI Biotyper）による同定を行い，5 例は千葉大学真菌医学研究センターに遺伝子解析を依頼した。そのうち 3 例は質量分析の同定結果と一致し（*N. pseudobrasiliensis*：1 件，*N. cyriacigeorgica*：2 件），不一致の 2 件は質量分析で *N. araoensis*，*N. nova* と同定された菌株が，遺伝子解析ではそれぞれ *N. beijingensis*，*N. aobensis* と同定されていた。

Nocardia 属は発育に時間を要する菌であり，塗抹標本から疑い菌を見つけて培養期間を延長することが分離に欠かせない。慢性呼吸器疾患や治療反応性の乏しい症例には肺抗酸菌症や真菌症に加えて，放線菌症が疑われる。そのため患者情報や治療経過を把握した上での塗抹の観察や，適切な培養検査を実施しなければならない。質量分析の同定性能には限界があるが日常検査の中で近縁種の報告まで可能であり，遺伝子解析と同様の結果が得られる菌種もあるため有用である。菌種によって薬剤感受性パターンが異なることが知られており，副作用の観点から ST 合剤以外の薬剤を選択できるよう，より正確な菌名同定と薬剤感受性が実施できることが望ましいため，他施設と連携できる体制を整えることが重要である。

地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター　中央検査部
微生物検査室（058-246-1111　内線：5112）